

Wyzdrowienie jest *możliwe*

Zdrowienie to nie „brak objawów” — to pełnia życia mimo trudności. To nielinearna droga, którą da się zaplanować.

CZAS: 15 min 1 sesja + bieżąca refleksja

ŹRÓDŁO: Anthony (1993); Andresen i in. (2003); McGorry (1996, EIS); Jääskeläinen i in. (2013)

JAK UŻYWAĆ

Przeczytaj o **trzech wymiarach** zdrowienia i **pięciu etapach** drogi. Zaznacz, na którym etapie obecnie jesteś. Zapisz *jeden mały krok*, który możesz zrobić w tym tygodniu w kierunku następnego etapu — i jedną osobę, która może być Twoim sojusznikiem w tym kroku.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Anthony (1993) — twórca koncepcji zdrowienia (ang. *recovery model*) — pokazał, że pacjenci z psychozą *wracają do życia*, nawet gdy część objawów się utrzymuje. **25-50%** osób osiąga pełną remisję kliniczną (Jääskeläinen, 2013); **50-70%** — znaczącą poprawę funkcjonalną (WHO ISoS, 2001). Programy wczesnej interwencji (ang. *Early Intervention Services*, EIS) — RAISE (USA), EPPIC (Australia), OPUS (Dania) — **podwajają** szanse na recovery przy pierwszym epizodzie.

01 ☉ Trzy wymiary zdrowienia

KLINICZNE

redukcja objawów

Mniej głosów, słabsze urojenia, jaśniejsze myślenie. Mierzalne skalą. **Filary:** farmakoterapia + CBTp. To zdrowienie „medyczne”.

FUNKcjONALNE

powrót do życia

Praca, nauka, relacje, samodzielność, codzienna rutyna. **Filary:** wspomagane zatrudnienie (IPS), struktura dnia, sieć wsparcia.

OSOBISTE

sens, nadzieja, tożsamość

„Jestem kimś więcej niż moja choroba”. Sens, nadzieja, tożsamość poza diagnozą. **Filary:** peer-support, wartości, opowieść o sobie.

Te trzy wymiary **nie muszą iść równo**. Można żyć dobrze (osobiste recovery) z utrzymującymi się głosami (brak klinicznego recovery). Można odzyskać pracę (funkcjonalne), zanim ustąpią objawy. *Każdy wymiar liczy się osobno*.

02 → Pięć etapów drogi — Andresen i in. (2003)



Droga nie jest liniowa — można cofnąć się do wcześniejszego etapu, to normalne. Liczy się kierunek, nie tempo.

03 Cztery filary wczesnej interwencji

Programy wczesnej interwencji (ang. *Early Intervention Services*, EIS) — RAISE, EPPIC, OPUS — opierają się na **czterech filarach**, które razem dają najlepsze rokowanie po pierwszym epizodzie. Pojedyncze filary też pomagają — ale to ich *kombinacja* daje efekt 2× lepszego rokowania.

FILAR 1 · FARMAKOTERAPIA

Niskie dawki atypowych antypsychotyków — minimum, które działa. *Mniej* efektów ubocznych przy pierwszym epizodzie. Decyzja zawsze wspólna z psychiatrą.

FILAR 2 · CBTP

Terapia poznawczo-behawioralna dostosowana do psychozy. 16–26 sesji. **Rekomendowana przez NICE** (2014) dla wszystkich osób z psychozą.

FILAR 3 · PRACA Z RODZINĄ

Interwencja rodzinna (ang. *family intervention*) — Pitschel-Walz. Obniża wyrażane emocje (ang. *expressed emotion*, EE), redukuje ryzyko nawrotu o **20–25%**.

FILAR 4 · WSPOMAGANE ZATRUDNIENIE

Model IPS (ang. *Individual Placement and Support*): wsparcie w znalezieniu i utrzymaniu pracy. Praca jako **narzędzie zdrowienia**, nie efekt uboczny.

04 Moja mapa zdrowienia

GDZIE JESTEM TERAZ

— etap 1–5 z diagramu wyżej

MÓJ SOJUSZNIK NA TYM ETAPIE

— jedna osoba, do której mogę się odezwać

CO DLA MNIE ZNACZY „WYZDROWIEĆ”

— konkretnie, własnymi słowami

JEDEN MAŁY KROK W TYM TYGODNIU

— wykonalny w 20 minut

Klucz: Anthony (1993) napisał, że recovery to „głęboko osobisty, unikalny proces zmiany własnych postaw, wartości, uczuć, celów, umiejętności i ról — sposób życia satysfakcjonujący, z nadzieją i wkładem, nawet z ograniczeniami spowodowanymi chorobą”. Meta-analiza Jääskeläinen i in. (2013): **13,5%** osób osiąga pełną remisję, **do 50%** — znaczącą poprawę. Wczesna interwencja w ciągu pierwszych 2–5 lat *podwaja* szansę na dobry długoterminowy wynik (Marshall, 2005).